

Un travailleur autiste que vous accompagnez / coachez

Pour les coachs en emploi, les travailleurs de soutien à l'emploi et les mentors en entreprise
— soutenir un adulte autiste en emploi.

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un adulte se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Dans le bon rôle, c'est un super-pouvoir — profondeur, fiabilité, détection de motifs, honnêteté. Dans le mauvais environnement (open-space, interruptions constantes, attentes floues), cela entraîne du camouflage et un **burnout autistique**. En tant que coach ou travailleur de soutien, vous êtes souvent le pont entre un travailleur capable et un environnement de travail qui n'a pas été conçu pour lui : aidez à articuler les aménagements, protégez le focus et détectez la surcharge avant que le burnout ne s'installe.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Épuisé, perd des compétences, ne peut pas récupérer après le travail	Burnout autistique — distinct du burnout professionnel classique et de la dépression
« Tout va bien » au travail, s'effondre après	Camouflage intensif ; le coût est payé hors vue
Lutte avec l'open-space, les réunions, le bureau flexible	Les environnements à canaux multiples et imprévisibles taxent un système monotropique
Ne signale pas la douleur, les effets secondaires ou la surcharge	Différences d' intéroception ; « ne pas dire » ≠ « ne pas souffrir »
Veut tout par écrit ; évite les appels	La communication sur un canal unique réduit la charge

Essayez ceci

- **Aidez à articuler des aménagements raisonnables** (Loi sur l'égalité / ADA) : espace de travail calme, instructions écrites, moins de réunions, communication asynchrone, attentes claires.
- **Structurez le rôle autour de quelques « tunnels, pas de tâches » plus profonds** — minimisez les interruptions, regroupez le travail superficiel, protégez le flux.
- **Soyez le point de contact prévisible et sécurisant** — littéral, par écrit quand c'est utile, focalisé sur la charge et la récupération.
- **Prenez le burnout au sérieux** — s'il s'installe, la stratégie validée par les preuves est de réduire les exigences et de permettre le démasquage, et non de « persévérer ».
- **Misez sur leur expertise** — ils savent ce qui les aide ; aidez-les à formuler ces demandes.

Évitez ceci

- Conseils génériques sur les « compétences sociales » ou incitations à « persévérer » qui augmentent le camouflage.
- Assimiler une performance masquée et compétente à un état « tout va bien ».

- Prendre des décisions à *leur place* sans les impliquer.

Quand demander plus de soutien

Soyez attentif au **burnout autistique** et à la **suicidalité** — le burnout y est lié. Traitez les comorbidités (**TDAH/AuDHD, anxiété, dépression, sommeil et troubles GI**). Où le burnout est sévère, validez un temps d'arrêt, une réduction d'heures ou un changement de rôle comme récupération. Orientez vers la médecine du travail / services de soutien.

Si le travailleur est une femme

Les femmes diagnostiquées tardivement camouflent intensément et peuvent sembler « tout à fait ok » tout en étant épuisées en privé ; prenez au sérieux un schéma de différence et de surcharge, quelle que soit l'apparence.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Partie 3.4), le **Guide pour la famille** (Partie 4) et le brief **Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'individu.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Knight (2021, *tunnels not tasks*); Mantzalas et al. (2022). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.